

2025년 M3-1 호흡기 1차

51/68문제 – 전부 객관식. 60점 미만 필수 재시. 70점 미만은 선택 재시.

정답률 50% 이하 문항을 피드백 해주셨습니다. 피드백 문항은 정답률을 기재했습니다.

김현정 (6)

<호흡기 과정소개>

<폐기능 검사>

<호흡기 질환의 주요증상 / 호흡기 진찰 및 진단방법>(2)

1. 52세 여자가 한 달 전부터 기침할 때 목에서 피가 나와 병원에 왔다. 평소 기침, 가래는 자주 있었으나 호흡곤란은 없었다. 30갑년의 흡연자였다. 혈압 120/80mmHg, 맥박 66회/분, 호흡 18회/분, 체온 36.4도였다. 가슴청진 시 호흡음은 정상이었다. 가슴 X선 사진이다. 혈액검사 결과는 다음과 같았다. 가장 의심되는 진단은?(42.59%)

혈색소 13.0g/dL, 백혈구 8,300/mm³(중성구 63%, 림프구 20%, 호산구 ~%)
혈소판 350,000/mm³, C-반응단백질 0.5mg/L(참고치, <10)

- 1) 특발성폐섬유화증
- 2) 만성기관지염
- 3) 알레르기기관지폐아스페르길루스증
- 4) 폐암
- 5) 폐렴



2. 42세 여자가 건강검진에서 발견된 가슴X선 사진 이상으로 왔다. 기침, 가래, 발열은 없었다. 담배는 피우지 않았고, 당뇨, 고혈압, 결핵 병력은 없었다. 1년전 건강검진에서 가슴 X선은 정상이었다. 가슴진찰에서 이상 소견은 없었다. 가슴 X선 사진이다.검사는?(18.52%)

- 1) 피부경유 바늘생검
- 2) 기관지동맥조영술
- 3) 양전자방출단층촬영
- 4) 3개월 후 가슴X선 추적
- 5) 가래 항산막대균 펄바른표본



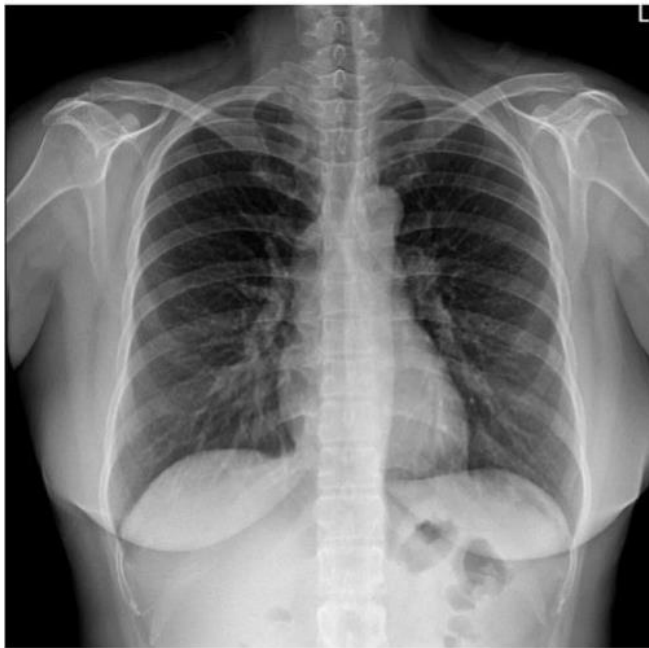
3. 27세 여자가 6주 전부터 발생한 발열을 주소로 내원하였다. 기침과 야간발한이 있었다고 하며 최근 4주 간 특별한 이유 없이 체중도 5kg 감소하였다고 한다. 가슴 X선 사진은 다음과 같다. 다음으로 시행할 가장 적절한 검사는?(22.22%)

- 1) 경피적 폐생검
- 2) 혈액 배양검사
- 3) 기관지 내시경
- 4) 투베르쿨린 검사
- 5) 혈청 아스페르길루스 침전항체



<기관지천식의 정의, 원인, 병태생리 / 기관지천식의 증상, 진단 및 치료>(2)

4. 35세 여자가 숨이 차서 응급실에 왔다. 1주일 전부터 오르막을 오를 때 가슴 답답함을 느꼈으나 크게 신경쓰지 않다가, 이틀전부터 콧물, 코막힘 등 증상이 생겨 오늘 아침 감기약을 지어먹은 후로 쌉쌉거리는 소리와 함께 갑자기 숨이 차기 시작했다고 한다. 병원에 내원하였을 때 쌉쌉거림이 해서 속효성 베타작용제를 흡입하였으나, 호흡곤란은 호전되지 않고, 지금은 말하기 어려울 정도로 숨이 차다고 한다. 혈압 160/90mmHg, 맥박 126회/분, 호흡 27회/분, 체온 37.2°C이고, 양쪽 폐에서 쌉쌉거림이 들렸다. 비강캐눌러로 산소를 2L 투여하고 산소포화도는 95%였다. 가슴X선 사진이다. 치료는?



- 1) 기관내삽관
- 2) 항생제 정맥주사
- 3) 에피네프린 피하주사
- 4) 지속성 베타 작용제 복용
- 5) 글루코코르티코이드 정맥주사

채민철 (2)

<가슴벽의 구조>

5. 흉곽을 구성하는 골격에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

1) 흉벽은 앞으로는 sternum, 바깥으로는 rib 과 근육, 뒤로는 vertebra 로 둘러 쌓여 있으며 호흡에 관여하고 심장, 폐, 대혈관 등을 보호해 준다.

2) Manubriosternal joint는 sternal angle이라 하며 thoracic vertebra 4-5번째 높이에 해당하며 종격동 내에서 aortic arch 및 tracheal bifurcation (carina) 가 위치하는 높이에 해당한다.

3) Manubriosternal joint의 양 옆으로는 1st rib의 costal cartilage 와 관절을 이루고 있는 sternocostal joint 가 있으며 측지를 하여 rib의 위치를 가늠할 수 있는 point가 될 수 있다.

4) Rib의 뒤쪽에는 head, neck, tubercle의 구조가 있으며 head와 tubercle 은 thoracic vertebra의 costal facet 과 관절을 이룬다.

5) Intercostal space는 rib 사이의 공간으로 rib 아래쪽에는 costal groove 가 있어 혈관과 신경의 통로가 되며 흉관 삽입 등의 침습적 처치 시에는 lower rib의 upper margin을 통해 접근해야 손상을 줄일 수 있다.

6. 횡격막에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

1) Musculotendinous structure이다.

2) Superior thoracic aperture를 구성하고 있다.

3) Esophageal hiatus 를 통해 esophagus 와 vagus nerve가 같이 통과한다.

4) 흡기시 근육이 수축되며 높이가 낮아지면서 흉강의 확장을 도와 호흡 운동에 있어 중요한 역할을 한다.

5) 횡격막 신경 손상시 횡격막의 수축과 이완이 사라지게 되며 횡격막 거상이 발생할 수 있다.

<폐의 구조>

7. 흉강 및 늑막에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

- 1) Visceral pleura와 Parietal pleura가 존재하며 둘 사이에 발생하는 공간을 흉강이라고 한다.
- 2) 흉강내에는 흉수가 존재하며 호흡에 따른 장기들의 마찰을 줄여주는 역할을 한다.
- 3) 종격동에 의해 좌우 흉강은 완벽히 분리되어 있다.
- 4) Visceral pleura는 Intercostal nerve의 지배를 받아 통증을 느낄 수 있다.
- 5) Visceral pleura와 Parietal pleura는 Hilum(폐문부)에서 연결되며 아래쪽으로 뻗어져 Pulmonary ligament 가 형성된다.

8. 폐 및 기관지에 대한 설명으로 바르지 않은 것은?

- 1) 기도는 불완전한 모양 (C-shaped)의 연골로 둘러싸여 있는 유연한 관모양의장기이다.
- 2) 좌측주기관지가 우측주기관지에 비해 더 긴 주행을 한다.
- 3) 우측폐는 3개의 lobe과 2개의 fissure, 좌측폐는 2개의 lobe과 1개의 fissure 로 구성된다.
- 4) Fissure는 각각의 lobe을 감싸고 있는 visceral pleura에 의해 생기는 경계이며 그중 right major fissure는 우하엽을 우상엽 및 우중엽과 구분시켜주는 경계가 된다.
- 5) 각각의 lobe은 해당 범위를 담당하는 기관지와 폐동맥, 폐정맥이 있으며 기능적으로 독립된 폐의 구역을 구분하는 가장 작은 해부학적 단위이다.

항일선 (4)

<호흡기의 해부학적 구조>

9. 기관과 기관지에 대한 설명이다. 맞는 것은?

- 1) 기관은 c자 연골을 가지고 후방에 평활근을 이룬다.
- 2) 기관의 연골판은 완벽한 고리 형태를 보인다.
- 3) 기관지는 섬모가 없는 편평상피세포로 되어 있다.
- 4) 기관은 점막하샘이 없고 기관지는 점막하샘이 풍부하다.
- 5) 호흡세기관지에는 연골이 있다

<호흡상피의 조직학적 구조와 기능>

10. 다음 중 혈액 가스 장벽을 형성하는 것을 모두 고르시오 (3개)

- 1) 제1형 폐포세포의 사이질
- 2) 폐포 상피와 모세혈관 내피의 융합된 기저막
- 3) 폐포 대식세포
- 4) H형 폐포세포의 핵
- 5) 모세혈관 내피의 사이질

11. type2 폐포세포에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 1) surfactant를 합성한다.
- 2) 복구에 기여하지 않는다.
- 3) 폐포 상피의 대부분을 구성한다.

<폐 병리학 용어, 급성 폐 손상, 폐쇄폐질환>

12. 심장성 폐부종에 대한 설명으로 옳은 것?

- 1) 직접적인 모세혈관 투과성 증가에 의한 것이다.
- 2) 좌심부전과 연관되어 폐모세혈관 압력 상승으로 발생한다.
- 3) 단백질 함유된 삼출물
- 4) 급성호흡곤란증후군의 병리학적 소견과 유사
- 5) 폐의 전반적인 침윤이 나타난다.

<감염성 폐질환>

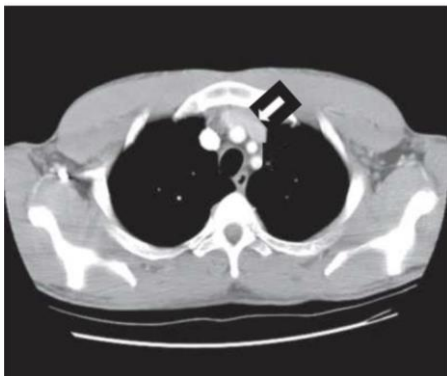
13. 세균성폐렴과 바이러스성폐렴에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 1) 세균성 - 사이질폐렴, 광범위폐포손상
- 2) 바이러스 - 고름 삼출물 잘 관찰됨.
- 3) 바이러스성 - 대식세포는 잘 관찰되지 않는다.
- 4) 세균성- 엽폐렴: 울혈기, 적색간화기, 회색간화기, 해소기
- 5) 세균성- 세포질 내 봉입체가 잘 보임.

금동윤 (1)

<뒷가슴벽의 구조>

14. 사진에서 화살표로 가리키는 구조물은?



15. IVC pulmonary thromboembolism에서 심장으로 우회할 수 있는 혈관은?

- 1) Intercostal vein
- 2) Azygos vein
- 3) left gastric vein
- 4) left brachiocephalic vein
- 5) hepatic vein

배재훈 (2)

<호흡생리학 1,2>

16. 33세 여자가 임신 35주에 조기산통으로 입원하였다. 분만의 진행을 중지시켰고 퇴원하여 엄격한 침대안정을 시행하였다. 3주후 분만을 위해 입원하였고 태아의 상태가 불안정하여 응급 제왕절제술이 시행되었다. 이를 후 환자의 우측 다리에 심한 통증을 호소하여 진통제가 처방되었다. 분만 4일 후 환자는 갑작스런 호흡곤란과 흉막성 통증을 호소하였다. 체온 37.5°C, 맥박 98회/분, 호흡수 20회/분, 혈압 139/80 mmHg이었고, 전혈구수검사(complete blood count) 이었다. 아래 동맥혈 검사 결과로부터 이 환자의 폐포-동맥혈 산소분압 차이(AaDO₂)값으로 가장 유사한 것은? 대기압은 760 mmHg이고, 호흡지수(R)= 0.8로 간주한다.

동맥혈검사: pH 7.45 ; PaCO₂, 32mmHg ; PaO₂, 55 mm Hg.

- 1) 15 mmHg
- 2) 25 mmHg
- 3) 35 mmHg
- 4) 45 mmHg
- 5) 55 mmHg

17. 장기간 흡연력이 있는 환자가 호흡곤란이 급성으로 악화하여 응급실에 왔다. 흉부 엑스선 사진에서 좌하엽의 음영이 증가하였다. 흉부 CT에서 종양이 좌하엽 기관지를 막아 좌하엽에 허탈이 관찰되었다. 이와 같은 결과로 보아 다음 중 이 환자 폐의 좌하엽에서 어떤 변화가 나타날 것으로 예상되는가?

- 1) 안지오텐신 I 에서 안지오텐신II로의 전환이 감소
- 2) 폐정맥압의 증가
- 3) 폐포의 혈관의 팽창
- 4) 폐동맥평활근의 수축
- 5) 폐정맥평활근의 이완

18. 가구공장화재에서 46세 남성이 구조되었다. 처음에는 호흡곤란, 어지럼증을 호소하다가 현재는 의식저하상태이다.

산소치료 중 동맥혈 산소포화도 99%였다. CXR 정상, Hb 15g/dL, 젖산이 상승해있다. 동맥혈가스분석 PO₂ 200mmHg, 폐동맥카테터 삽입 후 혼합정맥산소포화도 85%이다.

환자의 임상상황으로 적절한 것은?

- 1) 사이안화물중독
- 2) 폐부종
- 3) 저혈류 쇼크
- 4) 카복시헤모글로빈혈증

19. 혈액-가스 장벽의 가장 얇은 부분의 두께가 0.8이었다. (정상치 0.6) 일어나는 현상은?

- 1) 모세혈관 산소 확산 속도 감소
- 2) 기관지 원위부에서 폐포로의 확산 감소
- 3) Angiotensin I → Angiotensin II 전환 감소

박재석 (1)

<동맥혈가스분석과 저산소혈증>

20. 건강한 70세 COPD 남성. PCO₂ 70mmHg. pH 정상치보다 약간 낮았습니다. HCO₃⁻ 32mEq/L. 저산소증의 원인과 산염기 상태는?

21. PCO₂ 35mmHg, PaO₂ 50mmHg에서 산소 줬더니 PaO₂ 85mmHg로 호전됨. 원인은?

- 1) 폐기종
- 2) V/Q mismatch
- 3) 셉트

홍정희 (4)

<정상 흉부 영상의학 소견 및 검사법>

22. 다음 중 chest PA (후전위)에 대한 설명 중 맞는 것은?

- 1) X선의 방향이 환자 몸의 앞에서 뒤쪽으로 지나가는 검사이다.
- 2) 정상 Chest PA (후전위) 에서는 심장이 정상크기로 관찰되는 것이 특징이며 scapula가 양측 폐야를 가리지 않아야 하며, clavicle이 사선으로 위치해 lung apex를 가리지 않아야 한다.
- 3) 정상적으로 우측 횡격막이 7th 갈비사이공간 (intercostal space)에 위치하면 흡입 정도가 적당하다.
- 4) 노출 정도는 intervertebral disc는 보이거나, retrocardiac vascular marking이 보이지 않는 것이 적당하다.
- 5) 정상적으로 우측 횡격막이 좌측보다 약간 낮다.

23. 다음 흉부 전산화 단층촬영 (CT, computed tomography)에서 관찰되는 화살표 한 구조물에 대해 옳은 것은?



- 1) Acinus 폐세엽으로 영상검사로 관찰할 수 있는 가장 작은 해부학적 구조 단위이다.
- 2) 소엽중심구조물에 (Central core structure)는 폐동맥과 이와 같이 주행하는 세기관지 (lobular bronchiole)가 있다.
- 3) Respiratory bronchiole분지 이후의 구조물이다.
- 4) 결절의 위치가 소엽중심에 있을 경우, perilymphatic distribution이라고 한다.
- 5) 결의 위치가 소엽간중격(interlobular septum)에 위치할 경우 centrilobular distribution이라고 한다.

<흉부질환의 영상의학 소견 유형 분석>

24. 40세 여자 환자로 3일간의 누런 가래, 기침 주소 내원하였다. 혈압 120/80 mmHg, 맥박 90회/분, 호흡 25회/분, 체온 38.5 도였으며 오른쪽 가슴에서 거품소리가 들렸다. 환자의 chest PA와 left lateral 사진이다. 맞는 설명은?



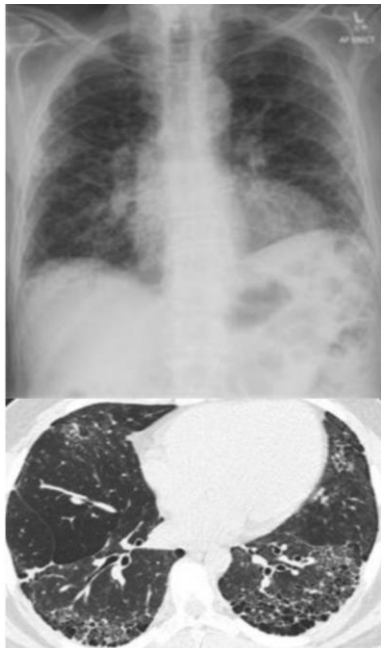
- 1) 좌상엽 설분절 폐렴이다.
- 2) 우하엽 폐렴이다.
- 3) 우중엽 폐렴이다.
- 4) 양쪽 흉수가 관찰된다.
- 5) 주된 소견은 간유리음영 (ground glass opacity)이다.

25. 다음 단일 폐결절이 발견되었을 경우 양성과 악성을 시사하는 영상의학적 소견 중 맞는 것은?

- 1) 악성 결절 석회화는 central, popcorn, laminated 모양으로 나타난다.
- 2) 악성 결절은 calcification을 보이지 않으므로 calcification이 보일 경우 양성 결절로 생각해야 한다.
- 3) 양성 결절 석회화는 ecentric, stipple한 것이 특징적이다.
- 4) 이전 사진과 비교할 수 있다면 양성 결절은 1-18개월 정도의 doubling time을 가지고 천천히 자라는 것이 특징이다.
- 5) 악성 결절은 margin이 주로 lobulated, spiculated한 양상이며 크기가 2cm 이상으로 큰 것이 특징이다.

<폐렴의 영상의학 / 기도 및 간질성 폐질환, 폐부종과 폐색전증의 영상의학>

26. 70세 남자가 6개월 전부터 기침을 한다며 병원에 왔다. 가래는 거의 없고 언덕을 오를 때 숨도 약간 찬다고 한다. 혈압 120/80mmHg, 맥박 78회/1분, 호흡 15회/분, 체온 36.8°C이다. 청진할 때 양쪽 등 아래부위에서 들숨 마지막에 거품소리가 들린다. 가슴 X선 사진과 가슴 컴퓨터 단층촬영이다. 옳은 설명은?



- 1) 하엽에 주로 생긴다.
- 2) honeycomb이 보인다.

27. 45세 남자가 심한 호흡곤란으로 응급실에 왔다. 혈압 180/110mmHg. Hb 7.0g/dL, BUN 106mg/dL, Cr 16mg/dL, Na/K 130/6.8mEq/L이었다. 흉부 X선 사진은 다음과 같다. 진단은?



- 1) 폐렴
- 2) 폐부종
- 3) 폐결핵
- 4) 폐암

김태훈 (5)

<상기도 질환과 급성기관지염>

28. 74세 남자환자가 "기침이 멈추지 않는다"를 주소로 내원하였다. 현재 흡연을 하는 1갑 * 50년 = 50갑년의 흡연자이며, 복용중인 약물은 없고, 4개월 전 코로나 바이러스 (SARS-CoV-2) 감염 병력이 있으나, 항바이러스제 복용 및 자택에서 회복하였다. 생체징후는 발열 없었다(혈압 120/80mmHg, 심박수 80, 호흡수 12). 가래증상과 콧물증상이 지속되고 있었고, 기침 증상은 5개월째 지속 중이며 최근에 악화중이다. 원인 질환에 대한 추가 검사가 권고되는 경고증상은?(31.48%)

- 1) 가래 증상
- 2) 콧물 증상
- 3) 8주 이상 지속된 기침
- 4) 흡연력
- 5) 최근 코로나 바이러스 감염 병력

29. 30세 남자환자가 “기침이 불편하다”를 주소로 내원하였다. 키 170cm, 체중 90kg이었
고(BMI 31), 1갑*5년 = 5갑년의 흡연자이며, 복용중인 약물은 없었다. 가래증상은 없었고,
콧물증상이 있었고, 후비루가 동반되어 있다. 위식도 역류증상이 있었다. 생체징후는 발
열 없었다. (혈압 120/80mmHg, 심박수 90, 호흡수 12). 이학적 검사상 호흡음은 이상이
없었다. 기침 증상은 6주 전 발생하였다. 환자에게 적절한 권고사항은? (46.3%)

- 1) 비염증상에 대해 부비동 컴퓨터 단층촬영을 한다.
- 2) 폐기능검사를 확인한다.
- 3) 상부 소화기내시경을 확인한다.
- 4) 호기 산화질소 검사를 확인한다.
- 5) 금연을 교육하고 대증치료를 시행하고 추적한다.

< 폐색전증의 임상소견과 진단 / 폐색전증의 치료 및 지방색전증>(2)

30. 34세 남자가 숨이 차고 오른쪽 다리가 부어서 내원하였다. 혈압 90/54 mmHg, 맥 박
120회/분, 호흡 25회/분, 체온36.5℃였다. 시행한 CT와 심전도는 다음과 같았다. 진단은?



- 1) 심근경색 2 심내막 3) 대동맥박리증 4) 폐색전증 5) 상대정맥증후군

(선지에 폐암이 있었습니다. 문제가 약간 달랐으나 답을 고르는 데에는 크게 차이 없었던
걸로 기억합니다.

31. 70대 여성 실신으로 내원. 내원 당시 혈압 70대/50대. 승압제 수액요법해도 변화없음.

(ct 폐색전증 사진 주어짐)

올바른 치료법?

- 1) 하대정맥 필터
- 2) 전신 정맥 혈전용해제
- 3) 즉시 경구 항응고제
- 4) 저분자량 헤파린 단독투여
- 5) 카테터?로 색전 제거?

32. 50세 여성 숨이 차다를 주소로 내원하였다. 과거력에서 원인미상 반복유산 4회 이력이 있었다. mMRC G2였고 혈압120/80, 맥박 80회/분, 호흡수18회/분이었다. 흉부 CT검사에서 폐동맥색전이 발견되었다. 혈액검사는 다음과 같았다. 투여해야하는 약물은?

CBC WBC10(4-10) HBG 12.5(12-16g/dL)

Lupus anticoagulant 2.1 (<2.0)

Anti cardiolipin Ab igM/igG (positive / positive)

Anti β 2 glycoprotein 1 Ab igM/igG (positive / positive)

- 1) 와파린
- 2) 리바록사반
- 3) 아픽사반
- 4) 다비가트란
- 5) 아가트로반

<환기장애, 수면무호흡>

33. 폐쇄 수면 무호흡의 진단 검사는?

- 1) 야간 코골이 증상
- 2) 두꺼운 목의 임상 지표
- 3) 수면 다원 검사
- 4) 폐기능검사

34. OSA 1차치료로 적절한 것은?

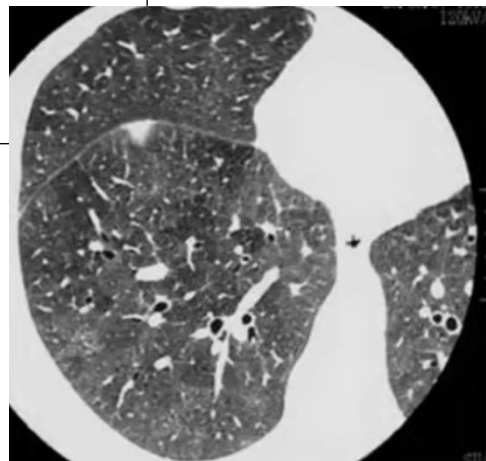
- 1) 하악전진술 (Maxillomandibular surgery)
- 2) CPAP
- 3) 항우울제 처방
- 4) 수면유도제 처방
- 5) carbonic anhydrase inhibitor 처방

<직업성 및 환경성 폐질환>

35. 47세 남성이 3일 전부터 시작된 호흡곤란, 기침, 오한과 발열을 주소로 내원하였다. 평소 농장에서 곰팡이 난 젖은 건초를 다루는 일을 한다. 최근 비가 많이 와 창고 환기가 잘 안되었다고 한다. 과거력은 특이사항 없으며 비흡연자이다. 진찰에서 호흡수 24회/분, 미세 crackle이 양측 폐저부에서 들렸다. 치료는?(25.93%)

CBC WBC 8.00k/uL(참고치:4-10), Neutrophil 50%,
HGB 13.5g/dL(참고치:11-15) PLT 516k/uL(참고치:130-400)
C-반응 단백질 0.1(참고치 0.0-0.5) 특이 IgG 항체 양성

- 1) 항생제
- 2) 전신 스테로이드
- 3) 산소치료
- 4) 폐절제술
- 5) 전폐 세척술



김미애 (7)

<폐렴 - 지역사회획득폐렴>

36. 52세 남성. 의식 명료. 혈압 115/80? 정상이었습니다

혈액요소질소 18. 치료는?

- 1) 외래에서 cefepime
- 2) 외래에서 amoxicillin
- 3) ~ 5)는 입원 후 항생제를 사용하는 선지였습니다.

<폐렴 - 병원획득폐렴, 흡인성 폐렴>

37. 70세 남자 환자가 고열, 호흡곤란을 주소로 내원하였다. 환자는 뇌출혈 이후 기관절 개관 통해 가정용 인공호흡기를 사용하며 거의 침상 생활을 하던 환자로, 4일 전부터 가래가 증가하며 미열이 있었다고 한다. 혈압 126/74mmHg, 맥박 81회/분, 호흡 20회/분, 체온 38.1도이다. 혈액검사와 영상검사 소견은 아래와 같다. 가장 적절한 치료는?(11.11%)

백혈구 23,250/mm³, 혈색소 16.7g/dL, 혈소판 211,000/mm³

C-반응성 단백질(CRP) 9.4mg/dL

- 1) 시프로플록사신(ciprofloxacin)
- 2) 독시사이클린(doxycycline)
- 3) 반코마이신(vancomycin)
- 4) 모시플록사신(moxifloxacin)
- 5) 클린다마이신(clindamycin)



38. 병원 입원 3일 후에 폐렴 걸린 사람. 다음 중 옳은 설명은?

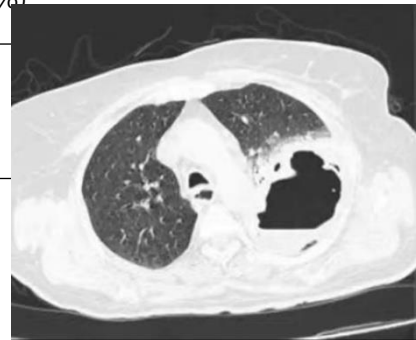
- 1) 90일 전에 항생제 정주 이력이 있으면 cefepime을 사용할 수 있다?
- 2) 30일 전에 항생제 사용 이력이 있을 때, MRSA 균 집락이 관찰된 적이 없다면 반코마이신을 쓰면 안 된다.
- 3) 손씻기는 예방에 도움이 되지 않는다.
- 4) 기계환기를 시행하는 경우 오래 해야 한다.

<폐농양과 기타 폐감염>

39. 60세 남자가 전신 쇠약감, 객혈로 내원하였다. 3주 전부터 기침, 가래, 발열이 있었고 이후 체중 감소, 피로감, 식욕부진이 동반되었고 발열과 오한, 냄새나는 객담을 동반한 기침, 객혈이 동반되었다. 청진 상 천명음이나 수포음은 들리지 않았으나, 좌측 폐에 성음 진탕이 증가되어 있었다. 구취, 치은염이 관찰되었다. 당뇨로 진단받았으나, 약물 복용은 하지 않았고 30갑년의 흡연력이 있었고, 매일 소주 1병씩 마셨다. 혈액검사 결과와 흉부전산화단층촬영 결과는 다음과 같았다. 치료는?(38,89%)

혈액 : 백혈구 21,000/mm³ 혈색소 13.5g/dL, 혈소판 187,000/mm³

객담 : 항산균 도말검사 음성, 결핵균 핵산 증폭검사 음성

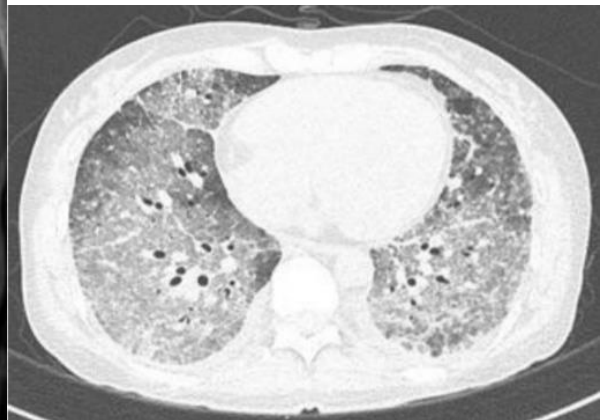


- 1) 경험적 항결핵제를 투여한다.
- 2) 수술적 제거 후 항생제를 4주동안 사용한다.
- 3) 기관지 내시경을 통하여 농양을 제거하고 광범위 항생제를 투여한다.
- 4) 경피적 카테터 삽입으로 배액을 시행하고 광범위 항생제를 사용 후 배양 검사 결과에 따라 항생제를 변경한다.
- 5) 경험적으로 혐기성 균도 치료할 수 있는 항생제를 영상학적으로 병변이 안정되거나 깨끗해질 때까지 장기간 투여한다.

40. 신장이식 받은 여자 항생제 이미 먹었는데 효과 없었음. 치료는?

- 1) ampicillin/sulbactam
- 2) azithromycin
- 3) vancomycin
- 4) trimethoprim-sulfamethoxazole
- 5) cefotaxime

41. 50세 여자가 마른기침, 발열, 호흡곤란으로 내원하였다. 1년 전부터 전신홍반루푸스로 진단받고 스테로이드 치료를 지속중이었다. 혈압 100/60 mmHg, 맥박 112회/분, 호흡 30회/분, 체온 39.5°C였다. 가슴 X선 사진과 가슴전산화단층촬영 사진이다. 원인으로 추정되는 미생물은?



- 1) pneumocysti jirovecii
- 2) aspergillus fumigatus
- 3) legionella pneumophila
- 4) Toxoplasma gondii

<폐결핵의 진단>

<폐결핵의 치료>

42. 환자가 소화기계 증상 (2가지 정도 구체적으로 제시함, 소화기계라는 단어는 쓰지 않음) 으로 내원함. 2주 전에 폐결핵 진단받고 1차 항결핵제 복용중. 다른 검사들은 이상 없었음. 의사가 할 말은?

1) 아직 중단하기에는 이르고, isoniazid rifampin pza ethambutol 중 RIF와 EMB는 그대로 복용하고 INH와 PZA는 아침 저녁 1정씩 나누어서 복용하자

2) 아직 중단하기에는 이르고, isoniazid rifampin pza ethambutol 중 1개는 그대로 복용하고 3개 중 1개는 아침, 2개는 저녁 약제 나누어서 복용하자.(정확하지 않습니다. 기억하기에는 4개 전부 아침 점심 저녁 나누어서 복용하거나 넷 중 하나는 그대로 두고 세 개를 나눠서 복용하는 내용이었습니다.)

(1,2 모두 약제 정확히 제시했습니다 Ex. H E는 그대로 복용하고 R P를 1정씩 복용한다-)

3) 부작용이 나타나서 항결핵제를 중단해야 한다.

4) 부작용이 나타났으니 rifampin 빼고 복용해야 한다.

5) 부작용이 나타났으니 2차 항결핵제로 바뀌어야 한다.

<만성폐쇄성폐질환의 진단, 치료>(2)

43. 70세 남자가 숨이 차서 병원에 왔다. 평소에도 기침, 가래가 있었지만 병원에 가지는 않았다고 한다. 50갑년의 흡연력이 있고, 한달전부터 계단을 오르거나 빨리 걸으면 숨이 찬다. 체중 감소나 부종은 없다. 혈압 128/80mmHg, 맥박 80회, 호흡 20회, 체온 36.4도이다. 청진 시 호흡음은 정상이었다. 가슴X선 사진이다. 검사는?

- 1) 기관지내시경
- 2) 가슴 컴퓨터단층촬영
- 3) 동맥혈가스분석
- 4) 폐기능검사
- 5) 메타콜린 기관지유발검사



44. 64세 남자가 기침과 가래를 주소로 병원에 왔다. 2년 전부터 기침과 가래가 있었으나, 5층 집까지 매일 걸어서 다녀도 숨이 차는 증상은 없다고 한다. 40년 전부터 지금까지도 매일 하루에 한 갑씩 담배를 피우고 있다. 폐기능검사와 흉부 X선 사진이다. 다음 중 가장 적절한 조치는? (37.04%)

기관지확장제 흡입 후
강제폐활량 : 정상예측치의 87%
1초간 강제날숨량 : 정상예측치의 72%
1초간 강제날숨량/강제폐활량 66%

- 1) 경과관찰
- 2) 점액용해제
- 3) 속효성 베타2항진제 흡입
- 4) 지속성 베타2항진제 및 항콜린제 흡입
- 5) 지속성 베타2항진제 및 저용량 글루코코르티코이드 흡입



45. 70세 남자가 3일 전부터 숨이 심하게 차다며 병원에 왔다. 수년 전부터 기침, 가래가 있었고, 평소에도 계단을 오르면 숨이 찼으나 3개월 전부터는 평지를 걷다가 쉬어야 한다고 한다. 10년 전부터 금연하였으나, 40갑년의 흡연력이 있었다. 1주일 전 감기 증세가 있었다고 한다. 혈압 135/80mmHg, 맥박 80회/분, 호흡 22회/분, 체온 36.5도, 산소포화도는 95%이다. 가슴 청진에서 양측에서 쌉쌉거림이 들렸다. 가슴 X선 사진이다. 가장 적절한 치료는? (5.556%)



- 1) 산소치료
- 2) 가슴관 삽입
- 3) 기관 내 삽관
- 4) 경구 글루코코르티코이드
- 5) 지속성 베타2항진제 및 저용량 글루코코르티코이드 흡입

박순호 (1)

<기관지확장증>

46. 31세 여자환자가 피석인 가래를 주소로 내원하였다. 어릴 때 홍역을 앓은 적이 있다고 하여 평소에도 누런 가래가 한번씩 있었다고 한다. 청진 상 오른쪽 아래 가슴에서 거품소리 가 들렸다. 가슴 X선 사진이다. 다음 중 시행할 적절한 검사는?



- 1) 심장초음파
- 2) 폐관류스캔
- 3) 기관지내시경
- 4) 폐동맥혈관조영술
- 5) 흉부전산화단층촬영

47. 70세 여성이 2개월전부터 가래에 피가 섞여서 내원했다. 20년전부터 기침과 가래가 많았으며 기관지가 안좋다는 말을 들어왔다. 혈압, 체온, 심음은 정상이나 양쪽 가슴 아래에 수포음이 들렸다. 가장 의심되는 질환은?

- 1) 기관지확장증
- 2) 폐흡충증
- 3) 폐암

이성용 (1)

<호흡기질환의 치료약제(1)>

48. Which of the following best describes the mechanism of action of B2-andrenergic agonist in acute asthma?

- 1) Stimulate adenylate cyclase that leads to increased intracellular cAMP
- 2) Inhibits phosphodiesterase that leads to decreased cAMP
- 3) Direct agonism to H1 receptor
- 4) Blocks transcription of inflammatory gene
- 5) Inhibits synthesis of leukotrine in bronchial wall

49. ICS에 대해 틀린 것은?

- 1) controller of chronic asthma
- 2) rapid bronchidilator of acute asthma
- 3) prevent EIA & nocturnal exacerbation
- 4) most effective antiinflammatory agents for asthma
- 5) decrease eosinophils, T cells, mast cells

장정희 (1)

<호흡기질환의 치료약제(2)>

50. 다음 중 말초의 기침 수용체의 구심성 경로를 통해 기침을 억제하여 부작용으로 드물게 QT 간격의 연장이 나타날 수 있는 약물은?

- 1) Ambroxol
- 2) Codeine
- 3) Chlorpheniramine
- 4) Dextromethorphan
- 5) Levodropropizine

51. Mycoplasma pneumoniae 감염으로 진단된 환자. CYP450 효소 저해가 적고, qt연장으로 인해 심혈관계 환자에게 주의가 필요한 약물은?

- 1) Levofloxacin
- 2) Rifampin
- 3) Azithromycin